Université de Bejaia
Faculté de Médecine de Bejaia
Module de Sémiologie Médicale
UE2

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

faculté de médecine de béjaia

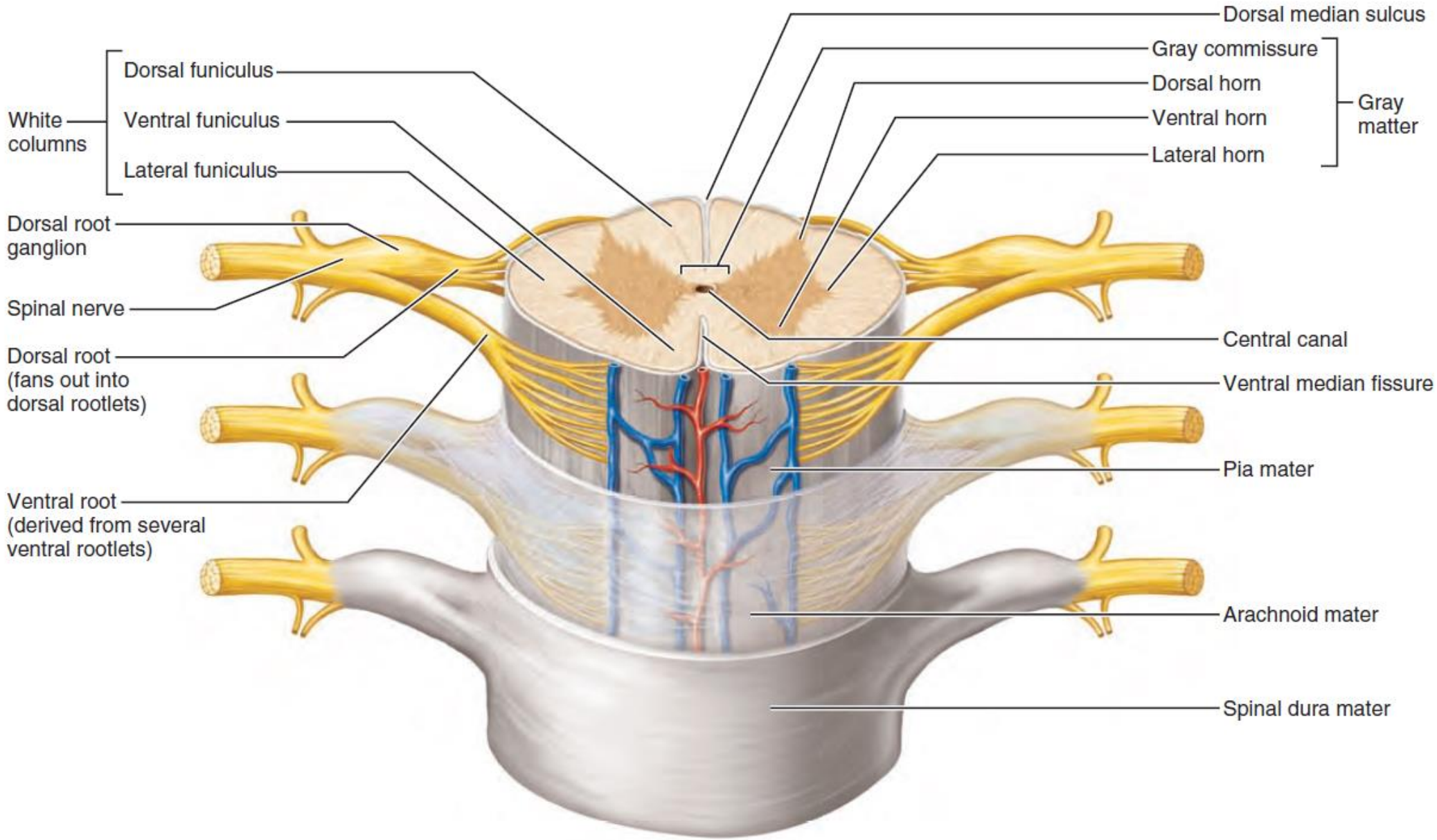
Sémiologie de la motricité 2

Les Paralysies périphériques
Syndrome neurogène périphérique

Dr Terra. Service de médecine interne du CHU Bejaia

paralysies périphériques

Moelle épinière



Le Système nerveux périphérique :

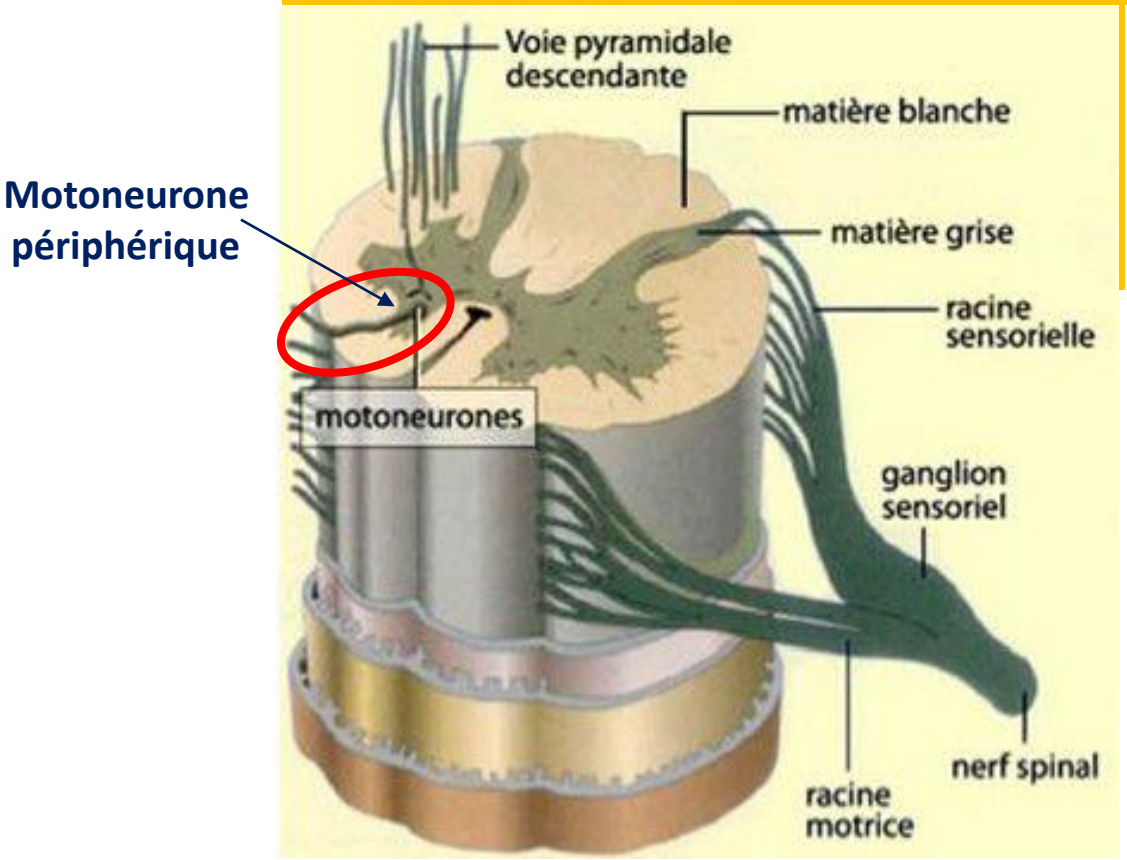
Un neurones moteurs (corps cellulaire dans la corne antérieure de la moelle)

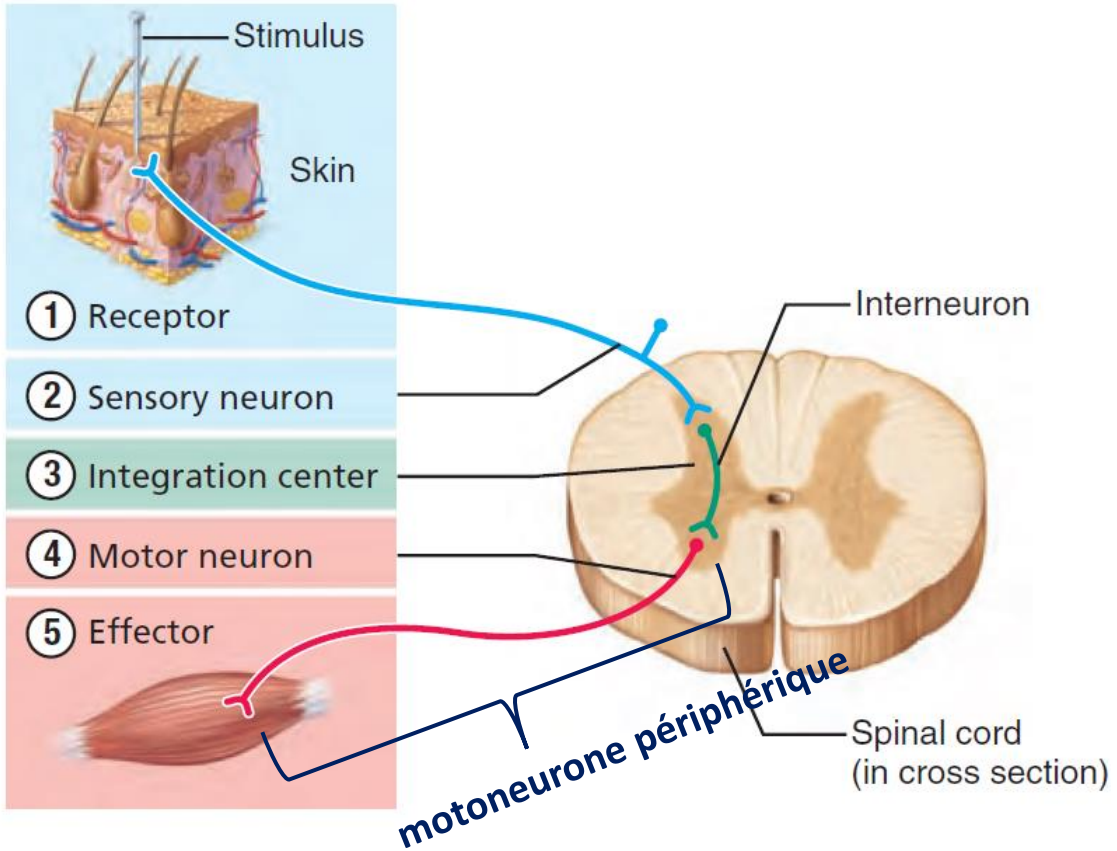
Un neurones sensitifs (corps cellulaire dans le ganglion spinal →racine dorsale)

Neurones végétatifs = Système Nerveux autonome

Syndrome neurogène périphérique

ensemble des signes cliniques liés à
l'atteinte du neurone moteur périphérique.





Syndrome neurogène périphérique

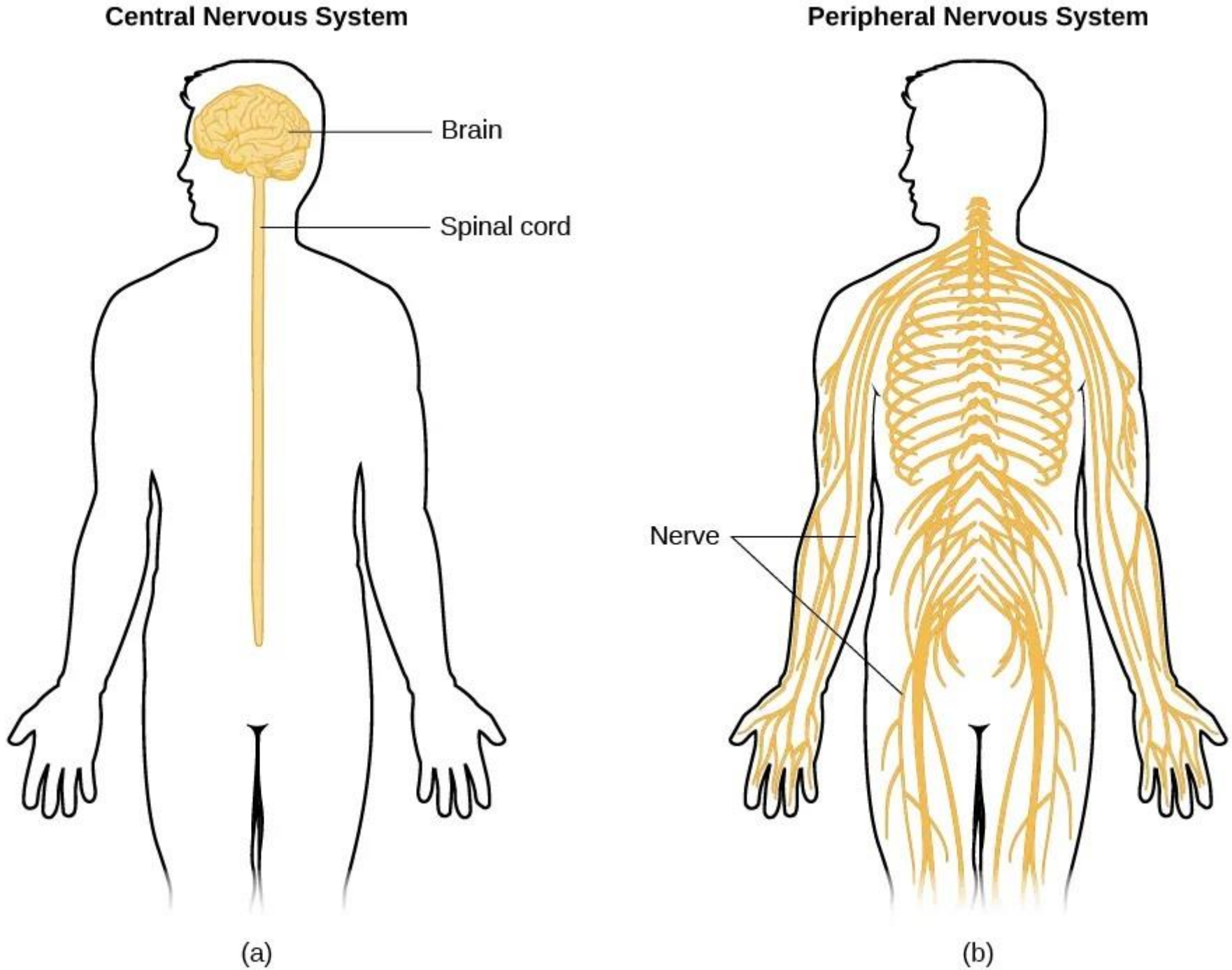
Atteinte du motoneurone périphérique :

→ corne antérieure de la moelle

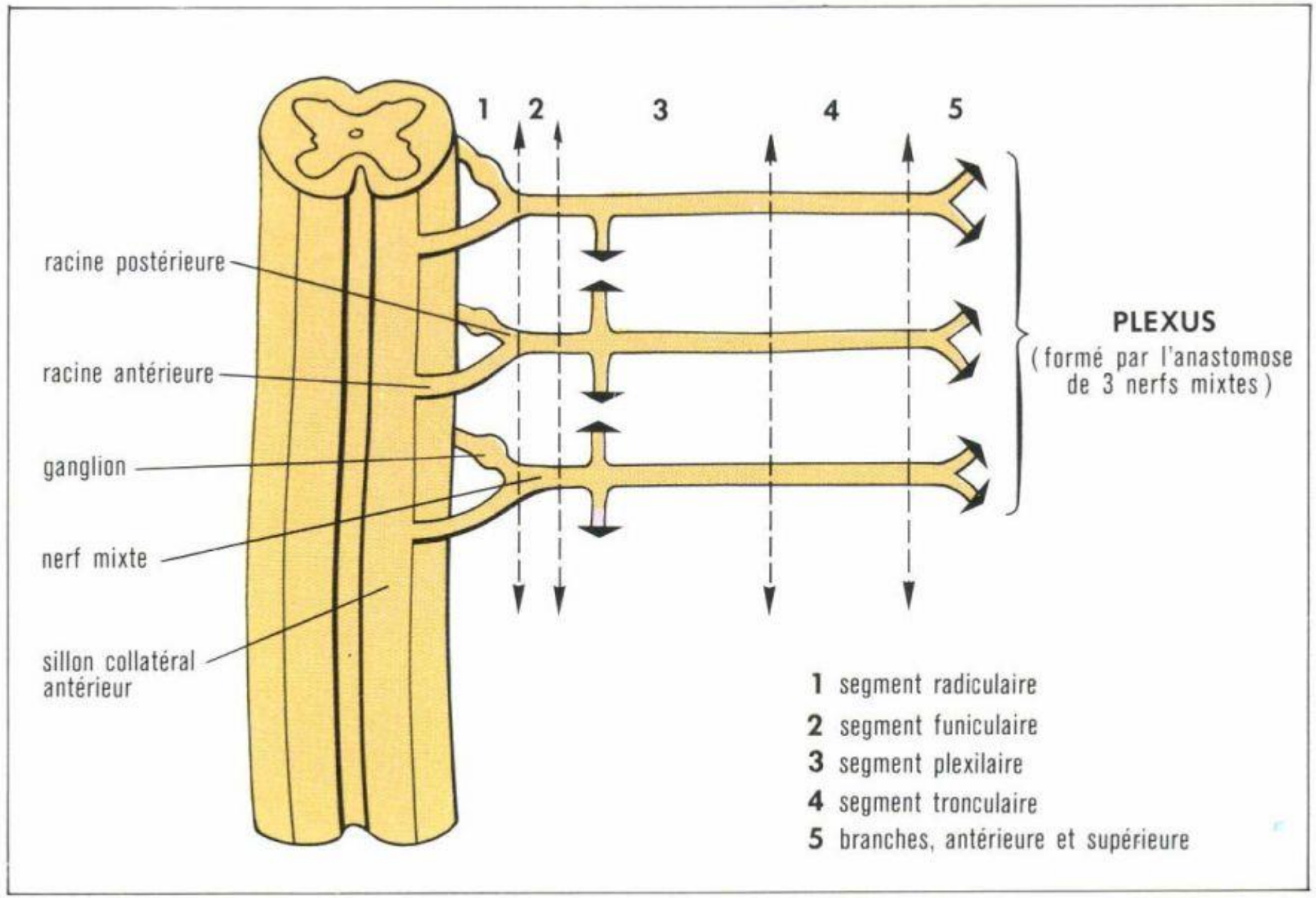
→ racines rachidiennes

→ plexus

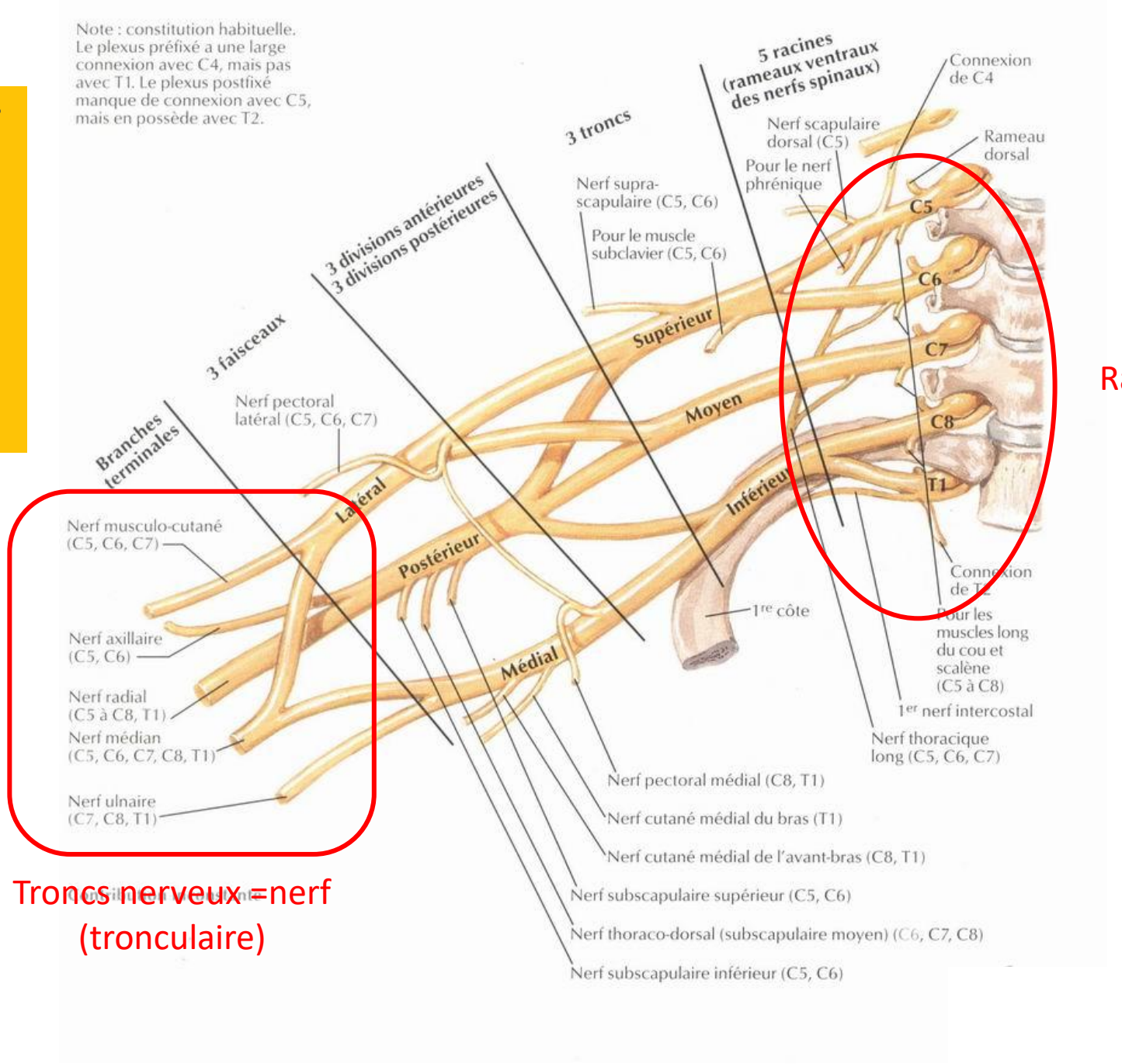
→ tronc nerveux


Central Nervous System
Brain
Spinal cord
(a)
Peripheral Nervous System
Nerve
(b)

Anatomie du système nerveux périphérique : les différents segments du nerf rachidien.



l'atteinte d'un nerf va entraîner la paralysie de plusieurs muscles

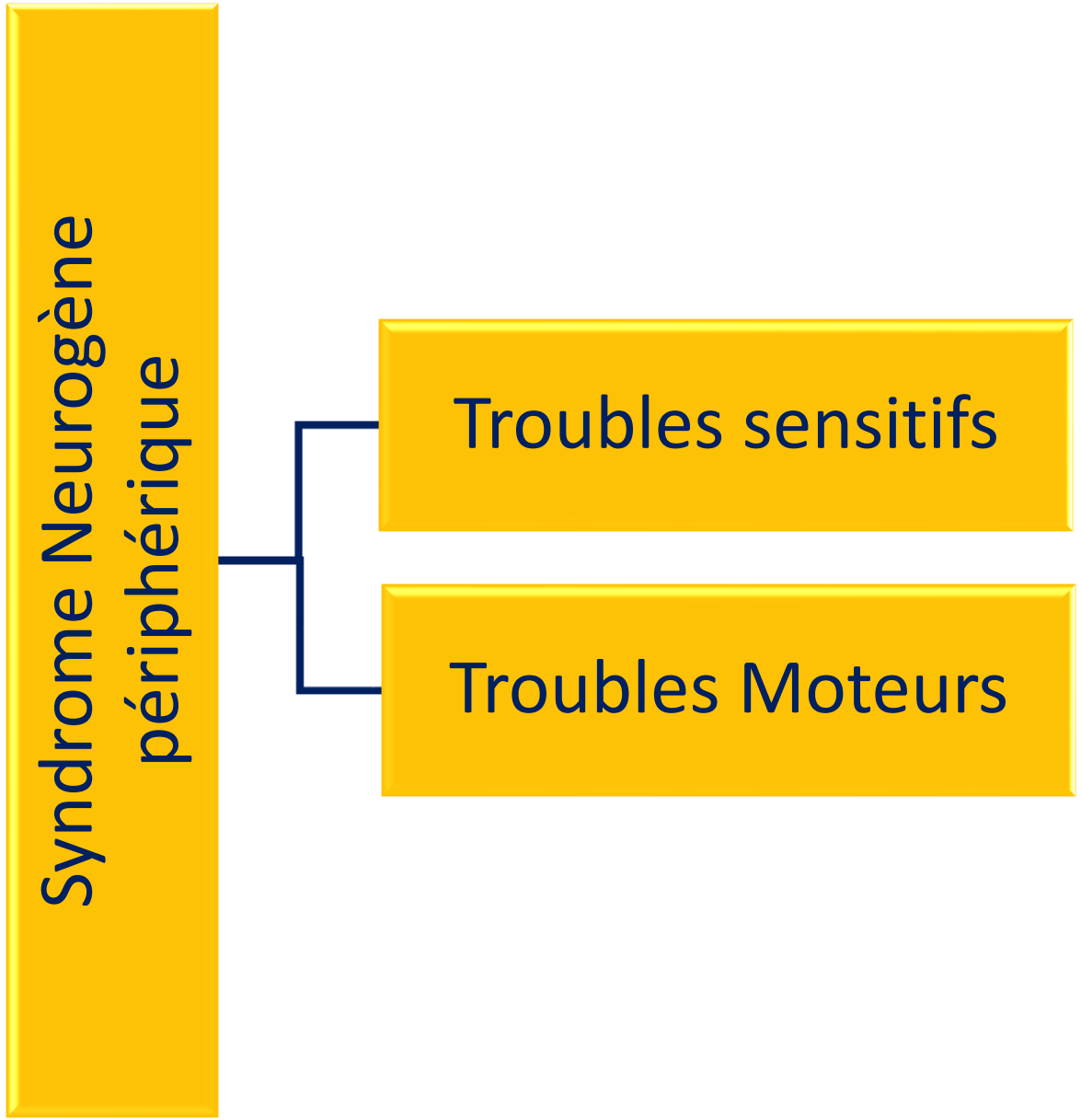


Racines nerveuses (radiculaire)

Troncs nerveux =nerf (tronculaire)

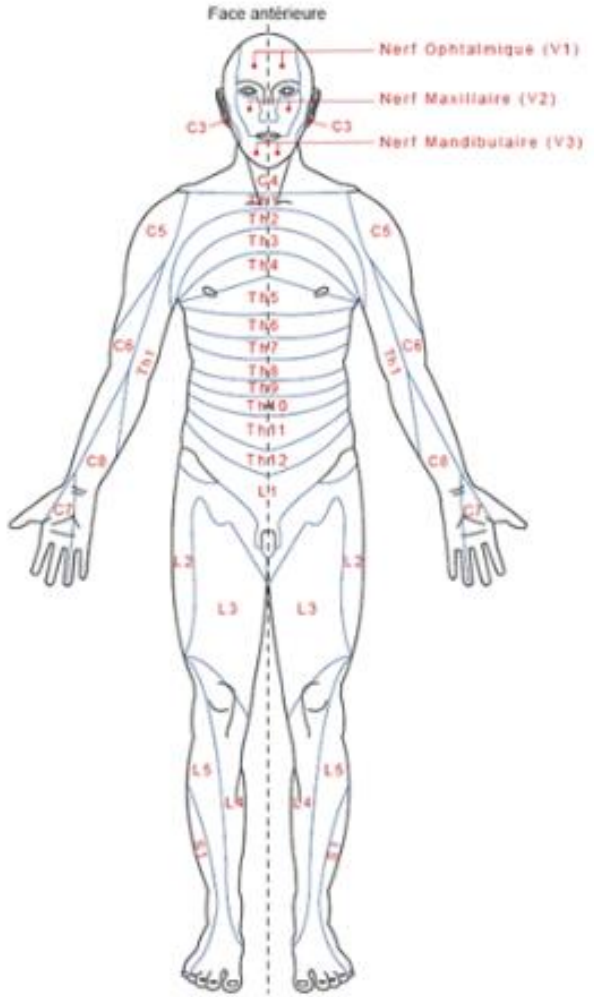
Sémiologie du système nerveux périphérique

Syndrome neurogène périphérique



atteinte du système nerveux périphérique

- **déficit moteur ou sensitif systématisé** à une ou plusieurs racines ou un ou plusieurs troncs nerveux



Syndrome neurogène périphérique : Troubles moteurs

- **Paralysie flasque :** topographie variable
  mais le plus souvent distale
- **hypotonie**
- **Diminution ou abolition des réflexes ostéo-tendineux**
- Absence de troubles vésico-sphinctériens

Signe négatif : Signe de Babinski

Syndrome neurogène périphérique : Troubles moteurs :

- Amyotrophie = (atrophie musculaire)
- fasciculations
- Troubles vasomoteurs :
    - cyanose
    - refroidissement
    - troubles sudoraux (sudation)

Syndrome neurogène périphérique : Troubles sensitifs :

Subjectifs : (anamnèse)

- douleurs : décharges électriques, brûlures, crampes au repos
- paresthésies

Objectifs : (examen clinique)

- hypoesthésie ou anesthésie complète portant sur tous les modes de sensibilité

Fasciculations

- contractions musculaires très brèves
- Superficielles
- localisées à une partie d'un muscle
- Sans mouvement musculaire
- spontanées ou après percussion du muscle

Amyotrophie



Syndromes topographiques

Le syndrome de la corne antérieure

- **paralysie flasque asymétrique** intéressant surtout les muscles proximaux : deltoïde au membre supérieur, quadriceps au membre inférieur
- **amyotrophie** importante, fasciculations ++
- absence de troubles sensitifs
- troubles vasomoteurs
- Observé au de la poliomyélite antérieure aiguë et la sclérose amyotrophique latérale (SLA) +++

Atteinte purement motrice

Neuropathies tronculaires

Neuropathies tronculaires

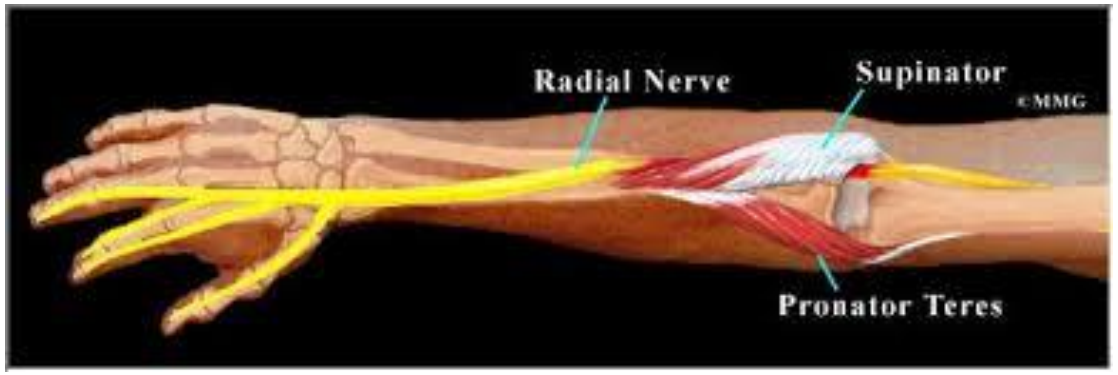
- Atteinte isolée d'un **tronc nerveux (nerf)**
- **déficit moteur** de topographie systématisée dans le territoire du nerf intéressé (touche les muscles innervés par le nerf)
- Amyotrophie
- **Troubles sensitifs :**
  - paresthésies dans le territoire du nerf
  - Douleurs neuropathiques +/-
  - Déficit sensitif à tous les modes

principales atteintes tronculaires :

- Nerf médian
- Nerf cubital
- Nerf radial
- Nerf sciatique poplité externe

Le nerf radial

- main tombante
- Attitude en flexion et pronation



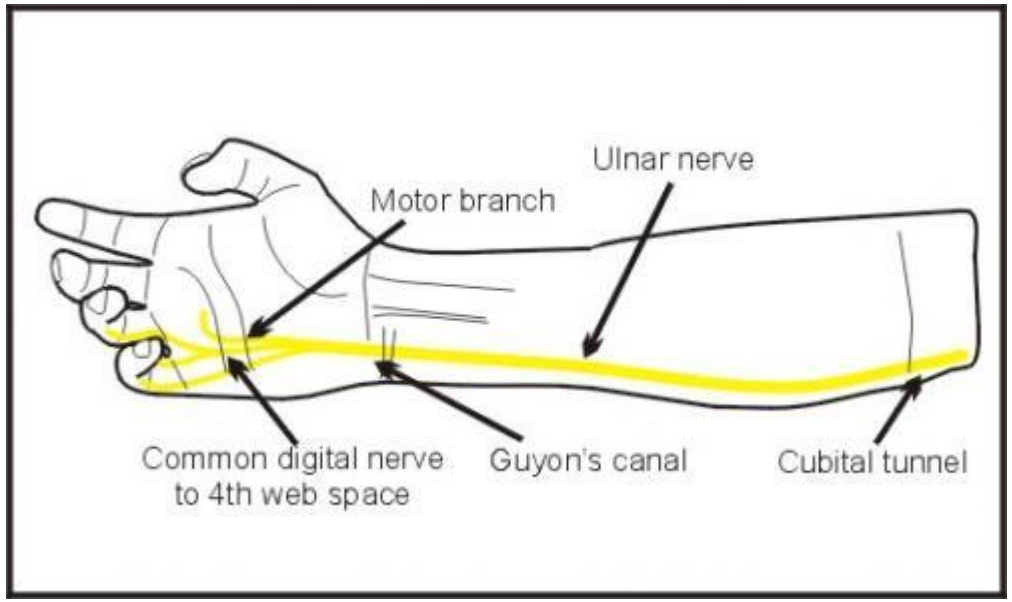




Paralysie radiale

nerf cubital

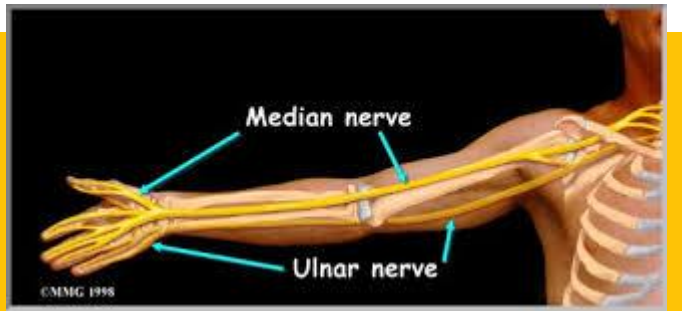
- main en griffe
- Flexion des 2 derniers doigts







nerf médian



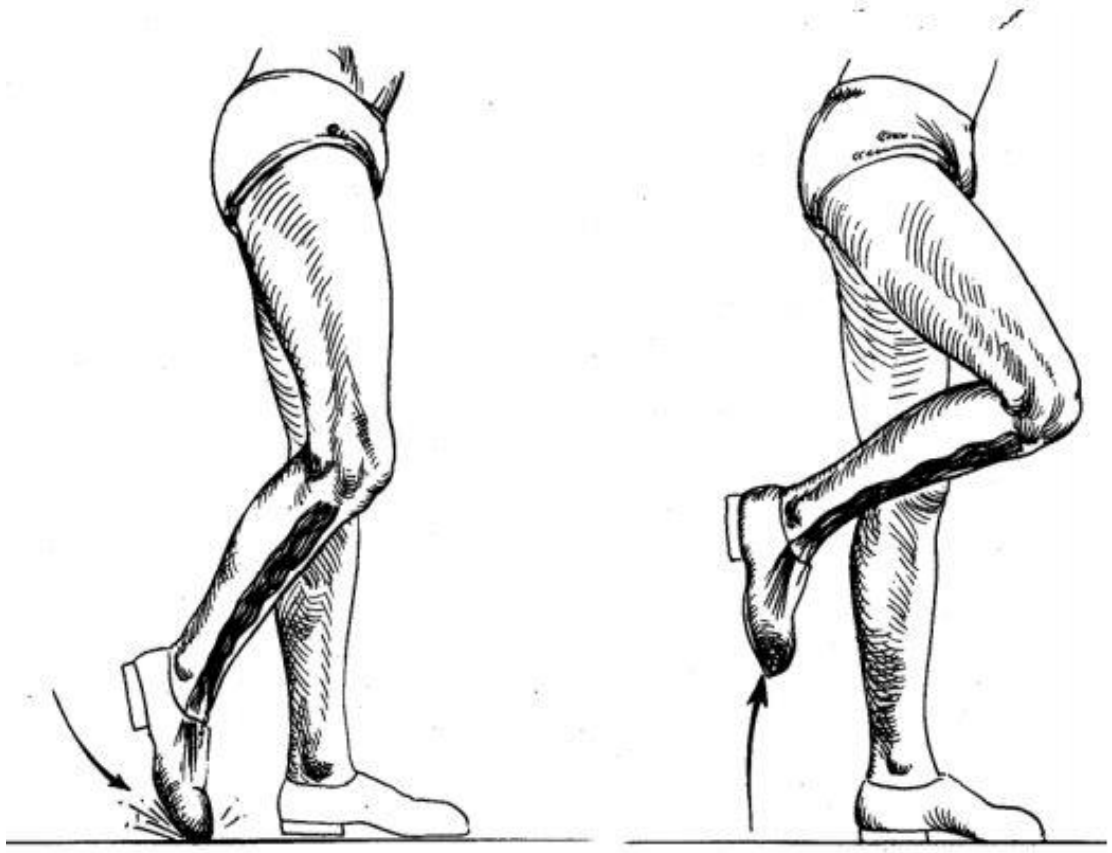
- Amyotrophie de la main
- paresthésies





sciatique poplité externe

- Steppage +++
- l'atteinte des muscles de la loge antéro-externe de la jambe
- Pied tombant, marche impossible sur talon



atteinte diffuse de plusieurs nerfs : Topographie

Symétrique

↓

Polynévrite

Asymétrique

↓

multinévrite

Neuropathies radiculaires

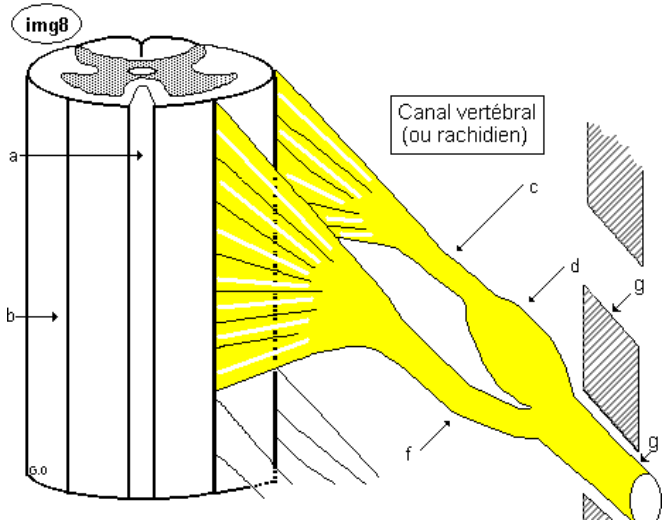
La douleur radiculaire (RADICULALGIE) :

- **naissance au niveau du rachis**

- **irradie** le long d'un **dermatome** selon un trajet systématisé

- associée à une rachialgie (cervicalgie, dorsalgie, lombalgie) selon la localisation de la racine

- **Exacerbée** par la mise en tension de la racine
(toux, éternuement, défécation, mobilisation du rachis)
et calmée par le repos.



syndrome radiculaire :

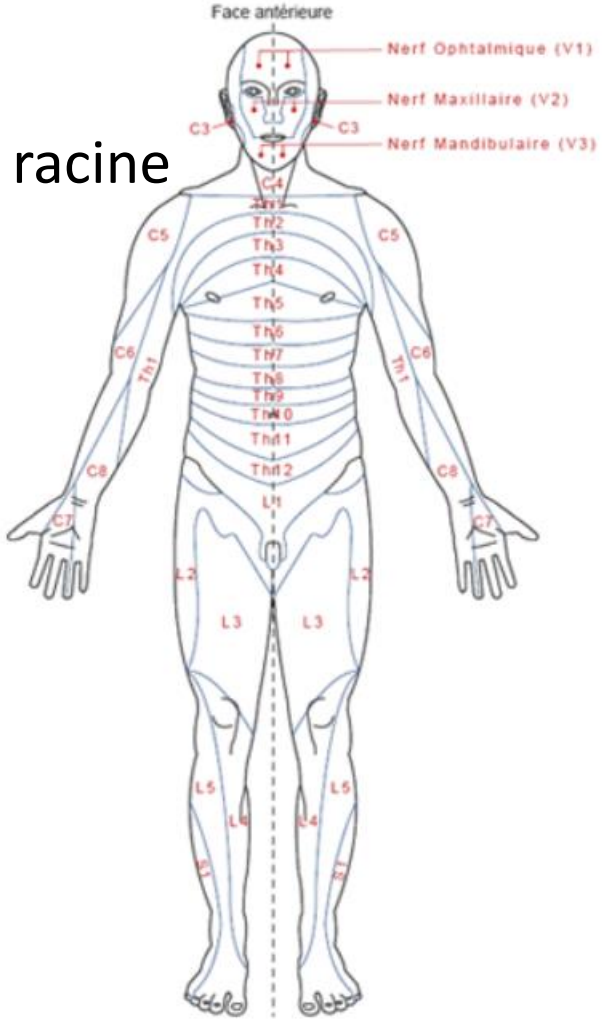
- **Reproduction de la douleur** par des manœuvres d'étirement de la racine

  Exemple : le signe de Lasègue dans les radiculalgies L5 et S1

- Déficit sensitif :rare, limité à la partie distale du dermatome

- **Les paresthésies** , inconstantes, systématisées à un dermatome

- Déficit moteur inconstant, systématisé



Signe de Lasègue

- Le signe de Lasègue correspond à une **limitation de la flexion sur le bassin, du membre inférieur en extension et en décubitus dorsal**

- La limitation est due à la douleur

- Oriente vers une atteinte radiculaire du nerf sciatiqu

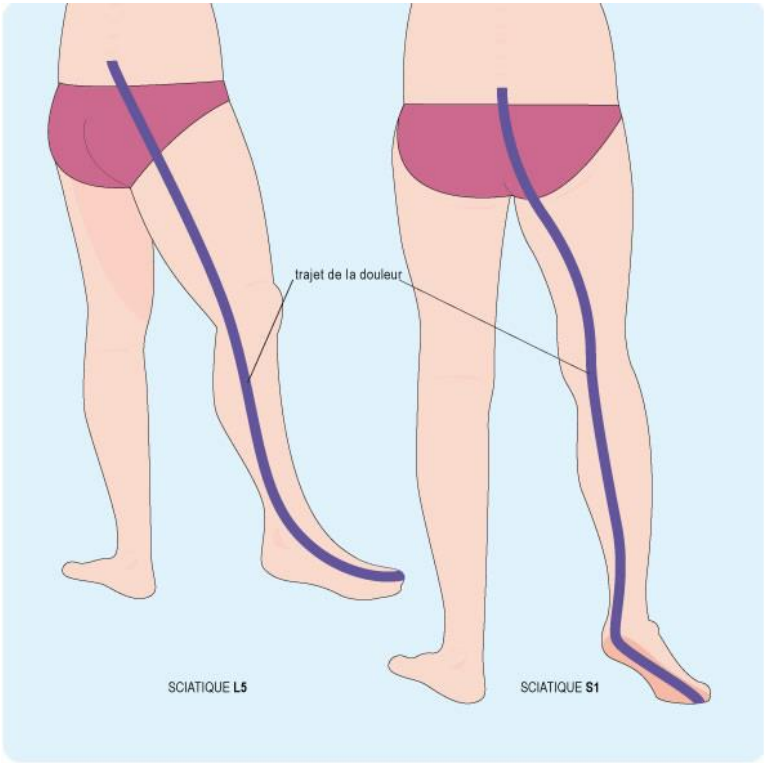


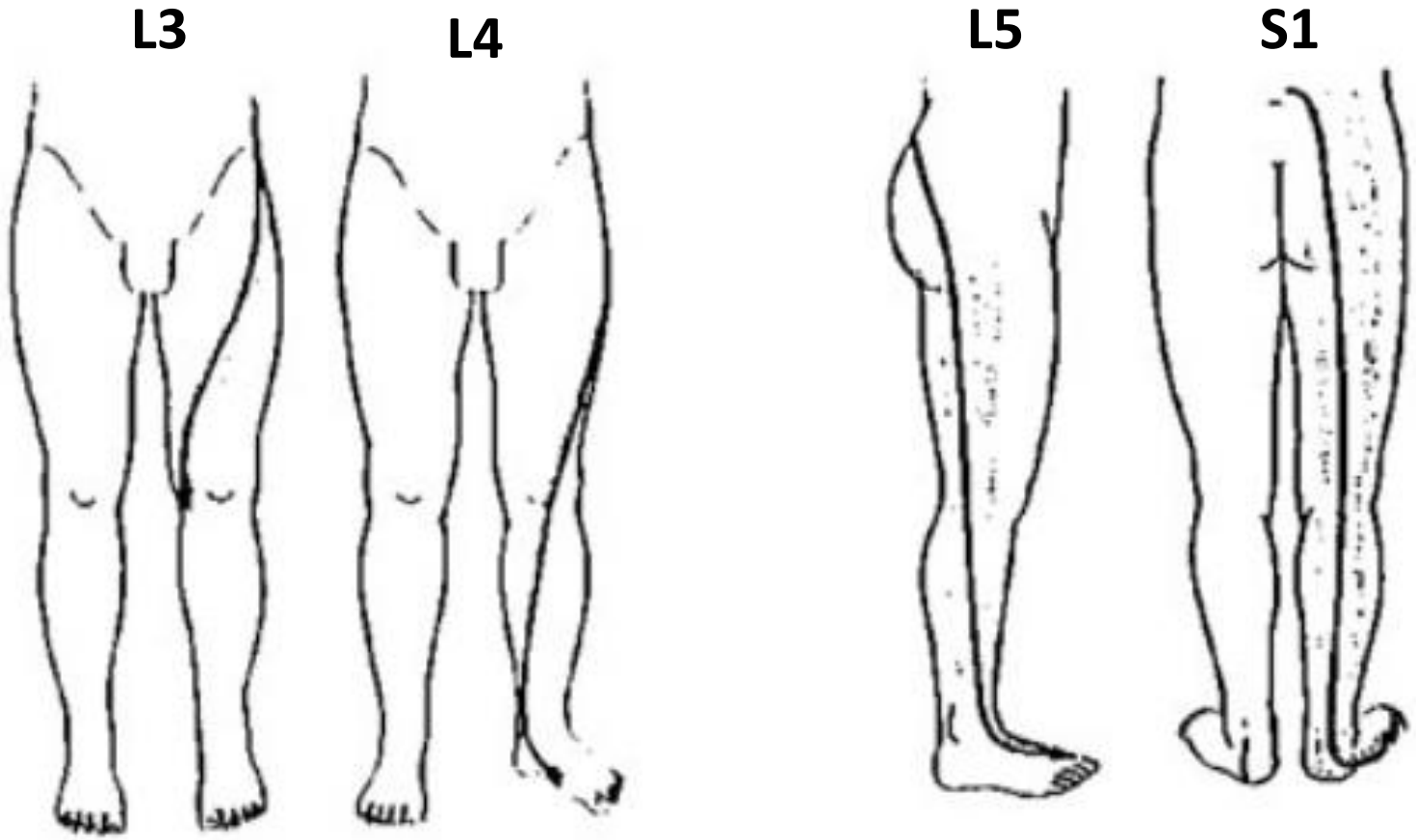
syndromes radiculaires

- Le syndrome mono-radiculaire : exemple : la sciatique L5 ou S1

- Le syndrome pluri-radiculaire : le syndrome de la queue de cheval lésion du siégeant au-dessous du cône terminal

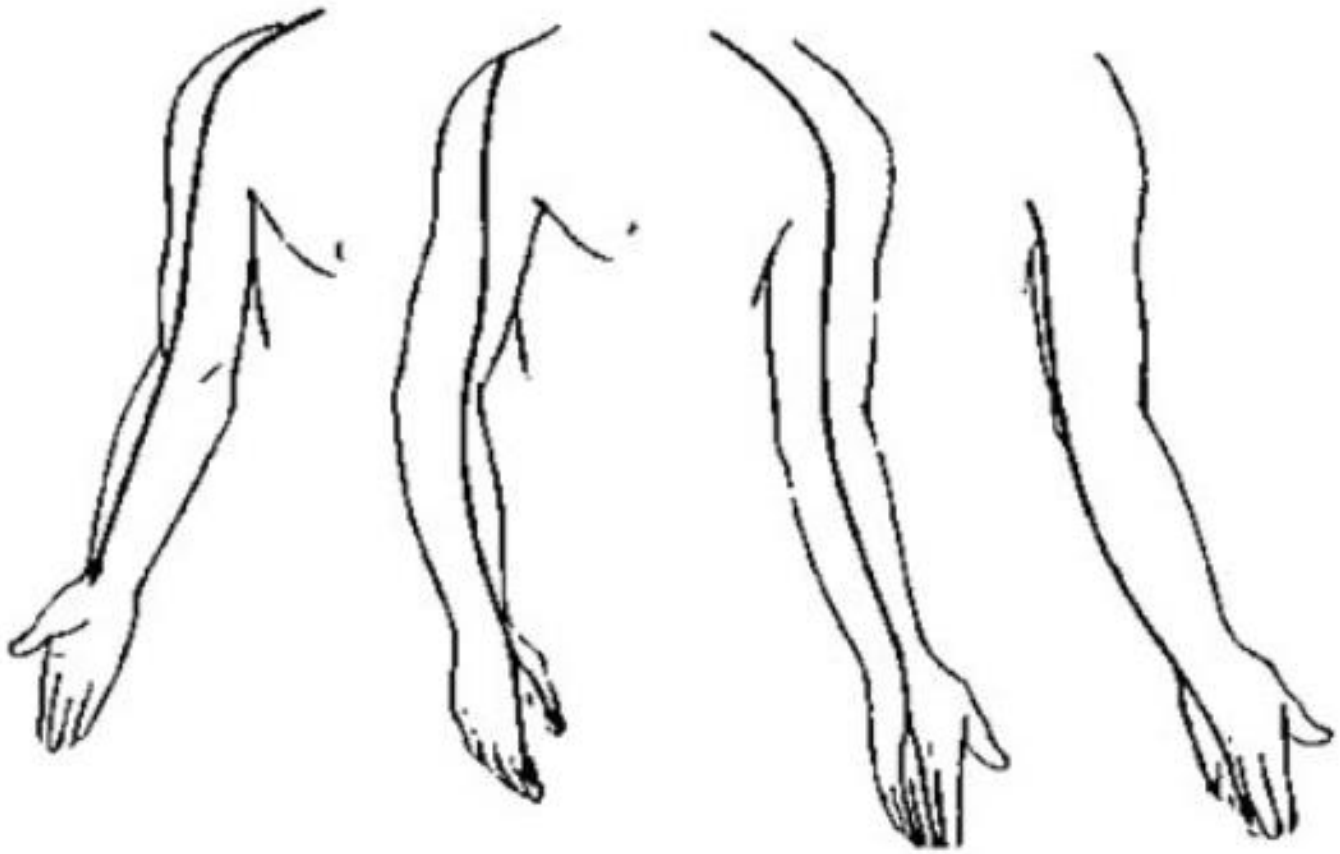
- Troubles sensitifs +++
- Troubles moteurs





TOPOGRAPHIE DE LA DOULEUR DANS LES SYNDROMES RADICULAIRES.
De gauche à droite : cruralgie L3 et L4, sciatique L5 et S1.

Syndromes radiculaires de la région cervicale



De gauche à droite : névralgie C5, C6, C7, C8.

Polyradiculonévrite

- Atteinte pluri-radiculaire

- **paralysies flasques et symétriques**
- **réflexes ostéo-tendineux abolis**

- troubles sensitifs : paresthésies

- paralysies des nerfs crâniens possible

Polyradiculonévrite

Aigue ou chronique

Forme aigue = syndrome de Guillain barré

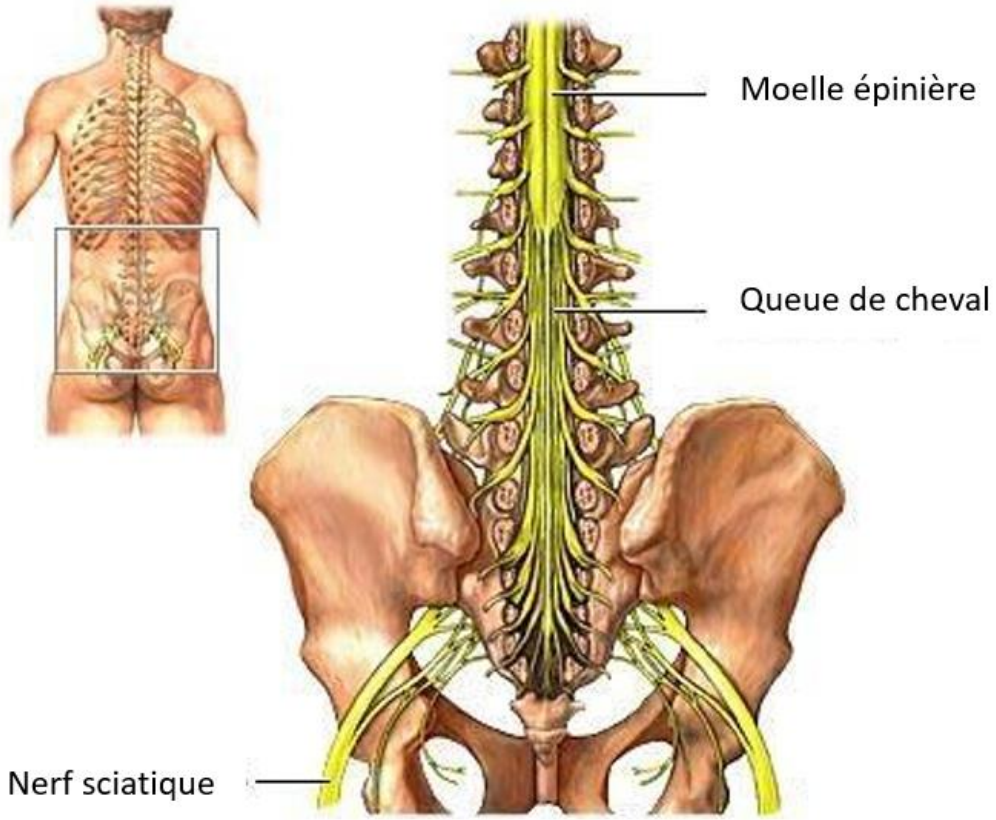
- Risque de troubles respiratoires
- Risque de troubles de la déglutition
- paralysie des 4 membres diffuse + tronc

Risque vital



Syndrome de la queue de cheval

- Syndrome neurogène périphérique
- Atteinte **pluri-radiculaire**
- **Membres inférieurs**



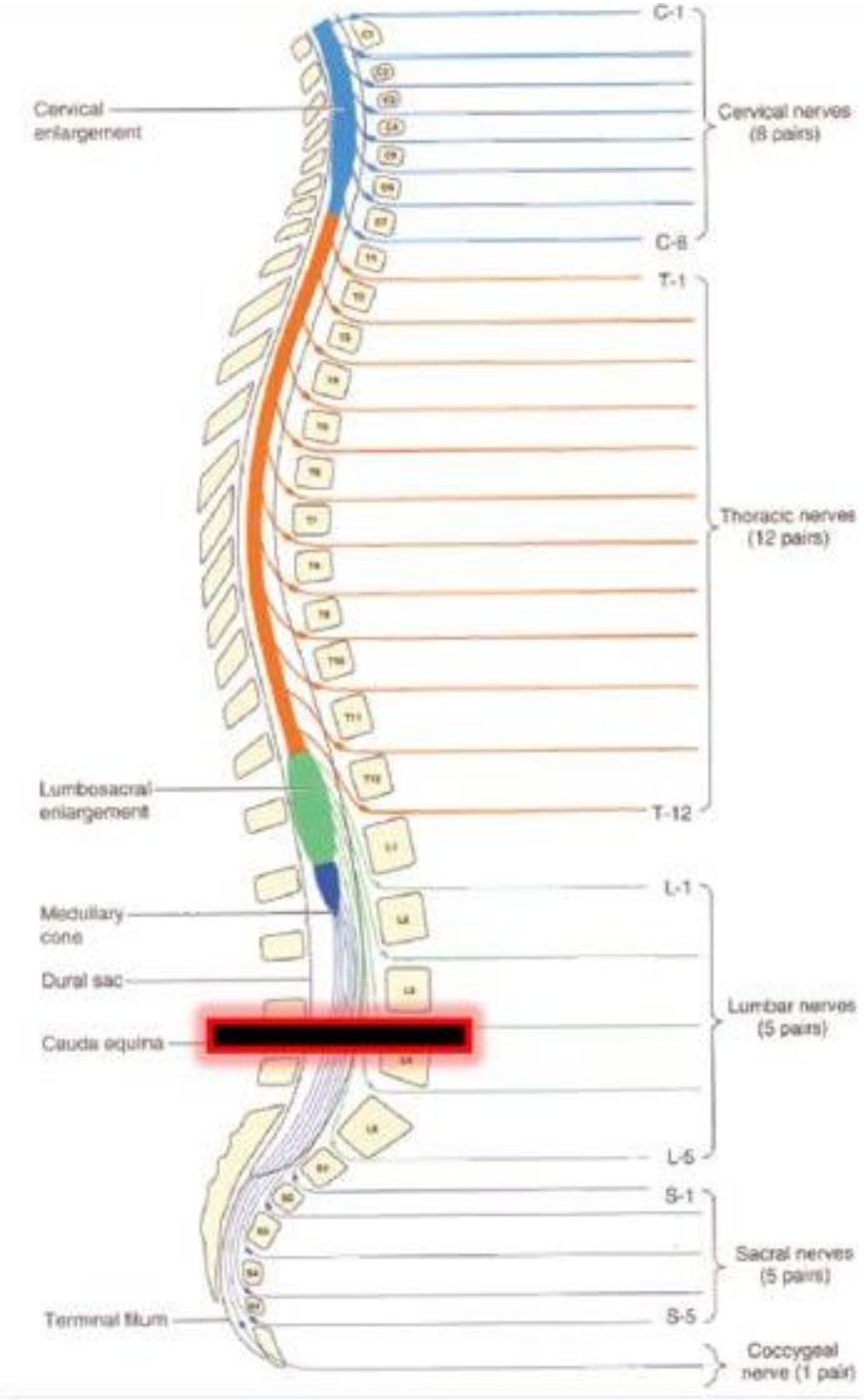
Syndrome de la queue de cheval

- Déficit **sensitif et moteur des membres inférieurs**
- **Reflexes abolis et hypotonie**

- Douleurs pluri-radiculaires des membres inférieurs
- (crurale, sciatiques)

- **Troubles génito-sphinctériens** :
  incontinence anale et vésicale

- **Anesthésie en selle** (région périnéale)



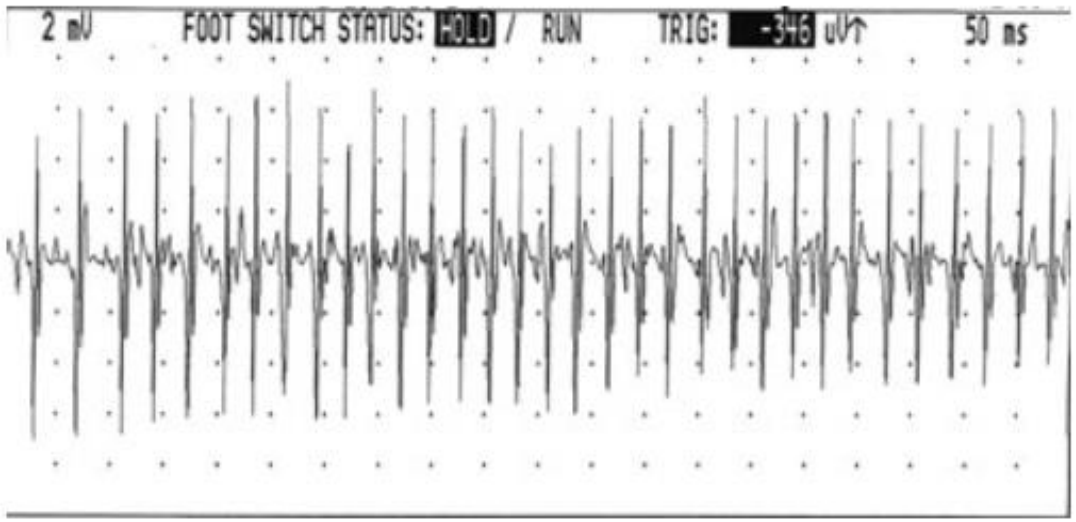
Syndrome neurogène périphérique : Examens complémentaires

Electromyogramme (EMG) :

- Examen de référence +++
- Confirme l'existence d'un syndrome neurogène → tracé neurogène
- Précise la topographie de l'atteinte
- Oriente vers la cause

Biopsie neuromusculaire :

Non indiquée pour le diagnostic, mais pour la recherche étiologique dans certains cas difficiles



Electromyogramme (EMG) :



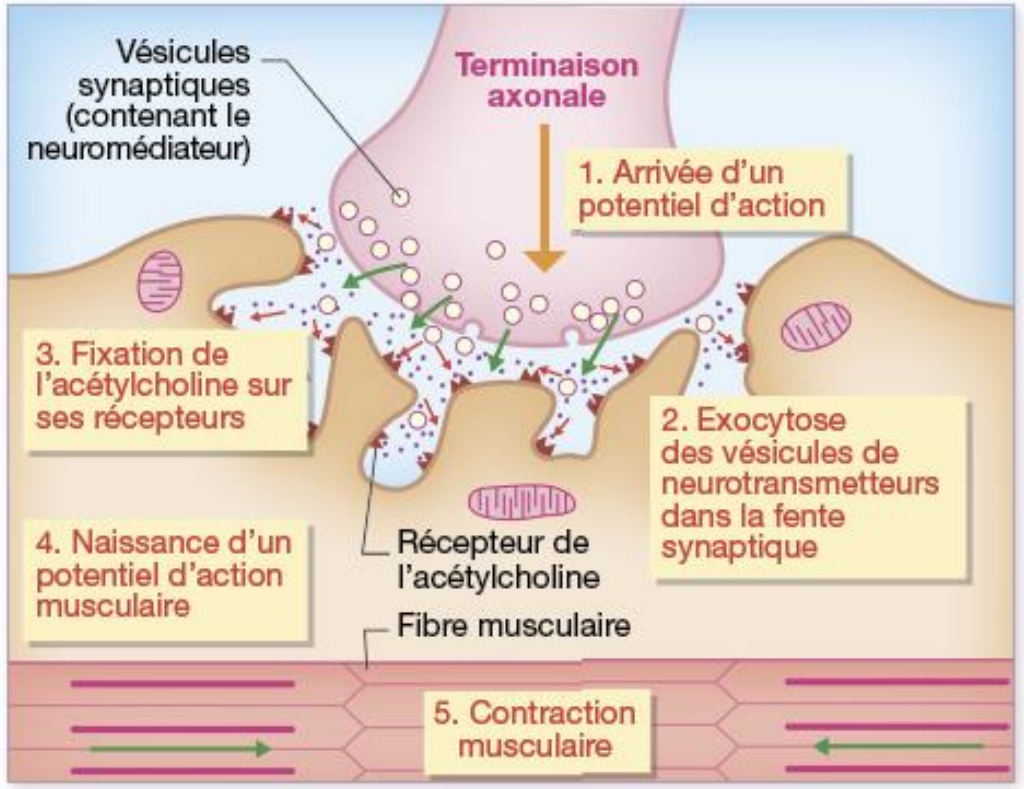




Atteinte de la jonction neuro-musculaire

Le syndrome Myasthénique :

- Atteinte de la jonction neuromusculaire
  - fatigabilité à l'effort
  - régresse au repos



Le syndrome Myasthénique :

- Les muscles oculomoteurs +++ :
  - Diplopie (vision double)
  - ptosis ++ (chute de la paupière supérieure)
- Les muscles masticateurs

- Les muscles des racines des membres

- **Gravité due à l'atteinte respiratoire +++ et les troubles de déglutition**





Myasthénie : ptosis bilatéral

Le syndrome Myasthénique :

Examen complémentaires :

- **EMG**:
  - bloc neuromusculaire

- **Immunologiques :**
  - Dosage anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine

Atteinte musculaire : Syndrome myogène

Atteinte primitive des muscles = syndrome myogène

- Fatigabilité musculaire
- Paralysies progressives, tardives
- prédominance aux **racines des membres** +++
- atrophie musculaire
- parfois une pseudo-hypertrophie, rare (mollets surtout)

Syndrome myogène

- pas de fasciculations
- absence de troubles sensitifs
- réflexes ostéo-tendineux conservés
- **abolition du réflexe idio-musculaire**
- Déficit moteur tardif, avec démarche dandinante

Syndrome myogène

Examen complémentaires :

- Biolgiques :
  - (enzymes musculaires)
  - ↑ des CPK (créatinine phospho-kinases)

- EMG :
  - tracé myogène

Merci pour votre attention